

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SOPS · SCALE OF PRODROMAL SYMPTOMS

Escala de Síntomas Prodrómicos – Instrumento psicométrico de cuantificación de severidad y seguimiento evolutivo de síntomas de riesgo de psicosis

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Scale of Prodromal Symptoms (SOPS)
Nombre en español	Escala de Síntomas Prodrómicos
Sigla oficial	SOPS (componente métrico de la SIPS)
Autores originales	Tandy J. Miller, Thomas H. McGlashan, Scott W. Woods, Kristin S. Cadenhead et al. (1999, 2003)
Adaptación hispanohablante	Red de Salud Mental CIBERSAM (Grupo de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Detección Temprana)
Año de publicación original	1999 (revisión 2003 y versión integrada SIPS 5.0 en 2010)
Constructo primario	Severidad y frecuencia de síntomas psicopatológicos positivos atenuados, negativos, desorganizados y generales
Formato de administración	Heteroaplicada por psiquiatra o psicólogo clínico mediante anclajes operativos de 7 puntos (0 a 6)
Población diana	Adolescentes y jóvenes (12 a 30 años) evaluados en programas de riesgo psicótico
Tiempo de aplicación	30 a 45 minutos (19 ítems clínicos)
Régimen de acceso	Uso clínico y académico abierto (Yale PRIME Clinic / CIBERSAM)

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Scale of Prodromal Symptoms** (SOPS) constituye el motor psicométrico cuantitativo embebido dentro de la entrevista SIPS. Mientras que la SIPS establece las reglas formales para categorizar los síndromes de alto riesgo (APSS, BIPS, GRD), la SOPS proporciona la métrica continua necesaria para calibrar con precisión milimétrica la intensidad, frecuencia e impacto funcional de cada síntoma prodrómico, permitiendo monitorizar la trayectoria del paciente semana a semana o mes a mes.

La escala estructura la semiología del riesgo en cuatro dimensiones psicopatológicas bien definidas: 1) **Síntomas Positivos (P1-P5)**, que evalúan la emergencia atenuada de distorsiones de la realidad (ideas mágicas, suspicacia, grandiosidad, alucinaciones atenuadas y lenguaje desorganizado); 2) **Síntomas Negativos (N1-N6)**, que capturan la merma precoz en expresividad, sociabilidad y volición; 3) **Síntomas de Desorganización (D1-D4)**, que reflejan anomalías cognitivas y conductuales; y 4) **Síntomas Generales (G1-G4)**, que miden la desregulación afectiva, ansiedad y disfunción somática. Cada ítem dispone de anclajes conductuales exhaustivos que diferencian de manera reproducible entre peculiaridades no patológicas (0-2), síntomas prodrómicos en umbral de riesgo (3-5) y síntomas psicóticos francos con pérdida del juicio de realidad (nivel 6).

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión SOPS	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Síntomas Positivos (P)	5 ítems	0 – 30	P1 (Contenido inusual de ideas), P2 (Suspiciacia/persecución), P3 (Grandiosidad), P4 (Anomalías perceptivas) y P5 (Comunicación desorganizada).
2. Síntomas Negativos (N)	6 ítems	0 – 36	N1 (Aislamiento social), N2 (Abulia), N3 (Expresión de emociones), N4 (Experiencia emocional/anhedonia), N5 (Ideación abstracta) y N6 (Higiene/autocuidado).
3. Desorganización (D)	4 ítems	0 – 24	D1 (Comportamiento extraño), D2 (Pensamiento confuso/distraibilidad), D3 (Atención deficiente) y D4 (Expresión del afecto incongruente).
4. Síntomas Generales (G)	4 ítems	0 – 24	G1 (Trastornos del sueño), G2 (Ánimo disfórico/depresivo), G3 (Ansiedad/angustia) y G4 (Tolerancia al estrés deteriorada).
Puntuación Total SOPS	19 ítems	0 – 114	Suma global directa de los 19 ítems (0 a 6 cada uno). Seguimiento dimensional de la carga mórbida.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Fiabilidad interjueces	CCI = 0.84 – 0.92 en subescalas	Excelente concordancia entre evaluadores formados; máxima fiabilidad en síntomas positivos (P: 0.92).
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.86 – 0.89	Alta coherencia interna global y en cada una de las 4 dimensiones en muestras clínicas hispanas.
Sensibilidad al cambio	Effect size d = 0.95 en seguimiento	Excelente capacidad métrica para capturar tanto la mejoría clínica como el empeoramiento hacia transición.
Validez de constructo factorial	4 factores ortogonales confirmados	La estructura factorial tetrapartita se reproduce fielmente mediante análisis factorial confirmatorio.
Correlación con PANSS	r = 0.78 con PANSS Positiva; r = 0.74 con PANSS Negativa	Fuerte correlación convergente con la escala estándar de síntomas psicóticos positivos y negativos.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación dimensional uniforme de 7 anclajes:**
 - **0 = Ausente:** Sin evidencia del síntoma; funcionamiento psicológico normal.
 - **1 = Dudoso:** Sintomatología ambigua, esporádica o dentro del rango de preocupaciones adolescentes normales.
 - **2 = Leve:** Síntoma discernible pero con escaso impacto en la conducta y rápida corrección con la lógica.
 - **3 = Moderado:** El síntoma interfiere de forma apreciable; el paciente reflexiona sobre él pero conserva insight.
 - **4 = Moderadamente severo:** Frecuencia semanal regular; angustia evidente; duda persistente sobre la realidad.
 - **5 = Severo pero no psicótico:** Síntoma casi continuo; el juicio de realidad oscila, pero el paciente aún admite la posibilidad de error.
 - **6 = Severo y psicótico: Pérdida del juicio de realidad;** convicción fija, inquebrantable o alucinaciones continuas.
- **Cómputo de Puntuaciones Parciales:** Se suma el valor bruto de cada dimensión: P (0-30), N (0-36), D (0-24) y G (0-24).
- **Puntuación Global SOPS:** Suma total de los 19 ítems (0 a 114 puntos).

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Nivel de Severidad	Categoría Psicopatológica	Implicación Asistencial y Criterio de Riesgo
Nivel 0 – 2 en Positivos	Subclínico / No EMAR	Fenómenos benignos o no patológicos. No requiere protocolo específico de riesgo de psicosis.
Nivel 3 – 5 en Positivos (P1, P2, P3, P4 o P5)	Umbral de Riesgo Atenuado (EMAR / CHR)	Punto de corte crítico de psicosis atenuada. Criterio de inclusión en programas de prevención temprana.
Nivel 6 en Positivos (P1, P2, P3, P4 o P5)	Nivel Psicótico Franco	Transición psicótica declarada. Pérdida total del juicio de realidad. Tratamiento activo del Primer Episodio Psicótico.

UMBRAL DE CONVERSIÓN PSICÓTICA EN SOPS (MILLER ET AL., 2003): Cualquier puntuación de **6** en alguno de los ítems de la subescala positiva (P1 a P5) que se presente durante ≥ 1 hora diaria en al menos 4 días por semana marca de forma incontrovertible la transición de estado prodrómico a psicosis abierta.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Valoración de la subescala Positiva (P1 a P5):

- Si ningún ítem P alcanza ≥ 3 : Explorar síntomas negativos y afectivos; derivar a salud mental ambulatoria general.
- Si algún ítem P puntúa entre 3 y 5: Activar protocolo de Estado Mental de Alto Riesgo (EMAR).

Paso 2: Monitorización longitudinal quincenal/mensual:

- Evaluar la trayectoria de las puntuaciones P:
 - **Trayectoria Descendente (Puntuaciones retornan a ≤ 2):** Buena respuesta al tratamiento psicoterapéutico y desescalada de estrés.
 - **Trayectoria Ascendente o Fluctuante:** Alerta clínica. Reforzar psicoeducación familiar y visitas de seguimiento.

Paso 3: Actuación ante la presencia de Nivel 6 en SOPS:

- La presencia de un 6 sostenido indica que el juicio de realidad se ha quebrado. Instaurar de inmediato antipsicóticos a dosis bajas (ej. Aripiprazol 5-10 mg/día o Risperidona 1-2 mg/día) e iniciar el abordaje integral del Primer Episodio Psicótico.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 19 años, estudiante universitaria de Biología, remitida por su tutor tras abandonar las prácticas y manifestar que los profesores la someten a pruebas mediante cámaras ocultas en el laboratorio.

Resultados en la Escala SOPS:

- **Subescala Positiva (P): 12 / 30**
 - P1 (Ideas de contenido inusual) = 4 (cree que hay un plan para evaluarla en secreto, aunque duda cuando su hermana razona con ella).
 - P2 (Suspiciosa) = 5 (hipervigilante, evita el contacto visual, analiza los gestos ajenos con recelo).
 - P4 (Anomalías perceptivas) = 3 (escucha murmullos al dormirse que la llaman por su nombre).
- **Subescala Negativa (N): 14 / 36** (N1 aislamiento = 4; N2 abulia = 4).
- Subescala Desorganización (D): 5 / 24; Subescala General (G): 8 / 24 (insomnio y ansiedad intensa).
- Puntuación Total SOPS = 39 / 114.

Intervención y Evolución: El perfil confirmó un estado de alto riesgo con síntomas positivos en rango 4 y 5 pero sin convicción delirante irreductible (sin nivel 6). Se inició TCC para psicosis incipiente focalizada en contrastar hipótesis alternativas y psicoeducación familiar. A los 3 meses de seguimiento con la SOPS, la puntuación en P2 descendió a 2 y P1 a 1, desapareciendo las anomalías perceptivas. Se logró el alta del programa EMAR a los 18 meses sin haber requerido antipsicóticos.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE MANEJO CLÍNICO:

- **Aparición abrupta de Nivel 6:** El tránsito de un nivel 5 (duda) a un nivel 6 (certeza delirante inamovible) puede ocurrir en cuestión de días ante un estresor agudo.
- **Disforia e impulsividad (G2 y G4):** La angustia generada por las vivencias de extrañeza eleva drásticamente el riesgo de conductas autolesivas en adolescentes.
- **Consumo de estimulantes:** El speed, cannabis y metilfenidato no prescrito pueden inducir puntuaciones positivas transitorias que falsean la evaluación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Distorsión perceptiva en migraña o epilepsia:** Descartar causas neurológicas en pacientes con anomalías sensoriales aisladas (P4 alta con P1/P2 en 0).
- **Fobia Social vs. Suspiciosa Prodrómica:** En la fobia social el paciente teme el juicio ajeno ("creerán que soy tonto"); en la suspiciosa prodrómica (P2) teme el complot o la malevolencia ("quieren dañarme").
- **TOC con ideas sobrevaloradas:** En el TOC las intrusiones son egodistónicas y van acompañadas de rituales neutralizadores.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Miller, T. J., McGlashan, T. H., Woods, S. W., Stein, K., Driesen, N., Corcoran, C. M., ... & Davidson, L. (1999). Symptom assessment in schizophrenic prodromal states. *Psychiatric Quarterly*, 70(4), 273–287. <https://doi.org/10.1023/A:1022034914902>
2. Hawkins, K. A., Addington, J., Keefe, R. S., Christensen, B., Perkins, D. O., Zipursky, R., ... & McGlashan, T. H. (2004). Neuropsychological status of subjects at high risk for a first episode of psychosis. *Schizophrenia Research*, 67(2-3), 115–122.
3. Woods, S. W., Walsh, B. C., Hawkins, K. A., Miller, T. J., & McGlashan, T. H. (2010). The PRIME Clinic: High-risk research and clinical care. In *Early Intervention in Psychosis: Theory, Research and Practice* (pp. 95–118). John Wiley & Sons.
4. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.